

Algodystrophie (Syndrome Douloureux Régional Complexe, Maladie de Sudeck)

Épidémiologie

- ❓ **Sexe** : Plus fréquent chez les femmes ($\text{♀} > \text{♂}$).
- ❓ **Incidence** : Plus courant à l'âge adulte, avec un pic d'incidence entre 40 et 50 ans.

Étiologie

- ❓ **Pathogenèse** : Inconnue. Les mécanismes hypothétiques incluent une réponse inflammatoire locale anormale, une sensibilisation centrale, une hyperalgésie et une hyperactivité sympathique due à une hypersensibilité aux catécholamines.
- ❓ **Déclencheurs** : Se développe généralement 4 à 6 semaines après un événement déclencheur, comme :
 - ❓ Traumatisme direct (fracture, entorse, blessure par écrasement, chirurgie, engelures, infection locale)
 - ❓ Événement vasculaire cérébral (AVC, infarctus du myocarde)
 - ❓ Grossesse
- ❓ **Idiopathique** : Dans environ 7 % des cas.

Facteurs de risque

- ❓ **Traumatisme** : Les fractures et les interventions chirurgicales sont les déclencheurs les plus courants.

Symptômes

- ❓ **Douleur** : Généralement dans un membre, plus prolongée et/ou plus intense que prévu compte tenu de l'événement déclencheur.
- ❓ **Anomalies sensorielles** : Hyperesthésie, allodynie.
- ❓ **Dysfonctionnement autonome** : Changements de température et de couleur de la peau.
- ❓ **Perte de fonction motrice** : Présente souvent des signes de dysfonctionnement sensoriel et moteur du côté affecté.

Diagnostic

- ❓ **Examen physique** : Douleur et signes de dysfonctionnement sensoriel et moteur.
- ❓ **Critères de Budapest** : Utilisés pour poser le diagnostic, plutôt que l'imagerie. Tous les critères suivants doivent être remplis :
 1. **Douleur persistante** :
 - ❓ Douleur plus prolongée et/ou plus sévère que ce qui est attendu compte tenu de l'événement déclencheur.
 2. **Symptômes rapportés par le patient** dans au moins 3 des catégories suivantes :
 - ❓ **Sensibilité** :
 - ❓ Hyperesthésie
 - ❓ Allodynie
 - ❓ **Vasomoteur** :
 - ❓ Hypo- ou hyperthermie
 - ❓ Hypo- ou hyperpigmentation de la peau
 - ❓ **Sudomoteur et/ou œdème** :
 - ❓ Hypo- ou hyperhidrose
 - ❓ Œdème
 - ❓ **Moteur et/ou trophique** :
 - ❓ Diminution de l'amplitude des mouvements et/ou de la force
 - ❓ Tremblements
 - ❓ Changements dans la croissance des ongles et des cheveux
 3. **Signes observés** dans au moins 2 des catégories ci-dessus lors de l'examen physique.
 4. **Exclusion** d'autres étiologies possibles (e.g., infection, radiculopathie, neuropathie, trouble vasculaire).

Traitement

- ❓ **Thérapie physique et médicale** : Initiées tôt, elles peuvent mener à une rémission. Les options incluent :
 - ❓ Corticostéroïdes oraux
 - ❓ Bisphosphonates

Tableau récapitulatif

Critère	Détails
Sexe	Plus fréquent chez les femmes ($\text{♀} > \text{♂}$)
Incidence	Pic entre 40 et 50 ans
Étiologie	Inconnue ; hypothèses incluent une réponse inflammatoire anormale, une sensibilisation centrale, une hyperalgésie, et une hyperactivité sympathique
Déclencheurs	Traumatisme direct, événement vasculaire cérébral, grossesse
Symptômes	Douleur disproportionnée, anomalies sensorielles (hyperesthésie, allodynie), dysfonctionnement autonome, perte de fonction motrice
Diagnostic	Basé sur les critères de Budapest, examen physique
Traitement	Corticostéroïdes oraux, bisphosphonates, thérapie physique

Notes supplémentaires

- ❓ Le diagnostic de SDRC repose entièrement sur des critères cliniques, car il n'existe pas de test diagnostique spécifique.
- ❓ Le développement de critères diagnostiques sensibles et spécifiques est difficile en raison de la présentation clinique hétérogène du SDRC.